

ECTÓPICA ROTA — CHOQUE = CIRURGIA JÁ

DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ ECTÓPICA

Aspecto	Detalhe
Tríade clássica	Atraso menstrual + dor abdominal/pélvica + sangramento vaginal
Localização	Tuba uterina (95% — mais comum); cornual, ovariana, cervical, cicatriz de cesárea
Beta-hCG	Positivo; em gestação tópica normal, sobe adequadamente; na ectópica costuma ser anormal
USG transvaginal	Ausência de saco gestacional intrauterino com beta-hCG acima do limiar discriminatório; massa anexial
Fatores de risco	Ectópica prévia, DIP/salpingite, cirurgia tubária, DIU, FIV, tabagismo
Beta-hCG discriminatório	Acima do limiar (~1500-2000) sem saco intrauterino visível = suspeita forte de ectópica

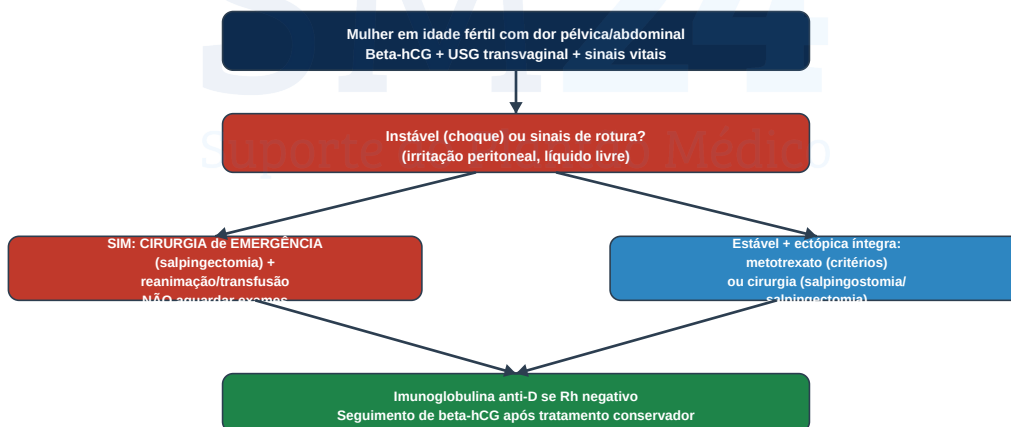
ROTURA = EMERGÊNCIA CIRÚRGICA

ABDOME AGUDO + CHOQUE EM MULHER EM IDADE FÉRTIL = ECTÓPICA ROTA ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO

- Sinais de rotura: dor abdominal intensa e súbita, sinais de irritação peritoneal, instabilidade hemodinâmica (taquicardia, hipotensão), dor no ombro (irritação diafragmática)
- Toda mulher em idade fértil com abdome agudo e choque deve ter beta-hCG dosado
- Instabilidade hemodinâmica = CIRURGIA DE EMERGÊNCIA (laparotomia/laparoscopia) sem aguardar exames adicionais
- Reanimação simultânea: 2 acessos calibrosos, hemoderivados, ativar protocolo de transfusão maciça se necessário
- FAST/USG com líquido livre + beta-hCG positivo + instabilidade = ir ao centro cirúrgico
- Salpingectomia geralmente na rotura; metotrexato NÃO tem papel na ectópica rota

ABORDAGEM

DOR + ATRASO + BETA-HCG -> ESTÁVEL?



TRATAMENTO — CIRÚRGICO vs MEDICAMENTOSO

Modalidade	Indicação	Observação
Cirurgia (emergência)	Rotura / instabilidade hemodinâmica	Salpingectomia; reanimação simultânea
Cirurgia (eletiva)	Ectópica íntegra com falha/contraindicação ao metotrexato	Salpingostomia (preservar a tuba) ou salpingectomia
Metotrexato	Estável, íntegra, beta-hCG baixo, massa pequena, sem BCF	Contraindicado na rotura e em algumas condições; seguir beta-hCG
Conduta expectante	Casos muito selecionados, beta-hCG baixo e em queda	Seguimento rigoroso
Imunoglobulina anti-D	Paciente Rh negativo	Prevenir aloimunização

REANIMAÇÃO E DIFERENCIAIS

Reanimação na Rotura

- 2 acessos venosos calibrosos; tipagem e prova cruzada
- Reposição volêmica e hemoderivados; ativar transfusão maciça se necessário
- Sangue O negativo de emergência se instável e sem tipagem
- Levar ao centro cirúrgico sem atraso (não postergar por exames)
- Monitorização contínua
- Comunicar a equipe cirúrgica e o banco de sangue

Diferenciais

- Abortamento (sangramento + dor, com gestação tópica)
- Cisto ovariano roto / corpo lúteo hemorrágico
- Torção de ovário
- Apendicite, DIP / abscesso tubo-ovariano
- Sempre dosar beta-hCG em mulher em idade fértil com dor pélvica
- Gravidez heterotópica (rara, mais comum pós-FIV)

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Beta-hCG em toda mulher em idade fértil com dor pélvica/abdominal
- ☐ Abdome agudo + choque + beta-hCG positivo = ectópica rota até prova em contrário
- ☐ Instabilidade/rotura: cirurgia de emergência (salpingectomia) + reanimação simultânea, sem aguardar exames
- ☐ Estável e íntegra: metotrexato (se critérios) ou cirurgia eletiva
- ☐ Imunoglobulina anti-D se Rh negativo
- ☐ Seguimento de beta-hCG após tratamento conservador; o metotrexato não tem papel na rotura

Suporte do Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Mulher em idade fértil com atraso menstrual, dor abdominal súbita intensa, hipotensão e taquicardia. Beta-hCG positivo e líquido livre na pelve. Qual a conduta?

- A) Metotrexato e observação
- B) Cirurgia de emergência (salpingectomia) com reanimação simultânea, sem aguardar exames adicionais
- C) Alta com analgésico
- D) Aguardar nova dosagem de beta-hCG em 48h
- E) Antibiótico para DIP

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a localização mais comum da gravidez ectópica?

- A) Ovariana
- B) Tuba uterina
- C) Cervical
- D) Cornual
- E) Cicatriz de cesárea

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Em qual situação o metotrexato é CONTRAINDICADO no tratamento da gravidez ectópica?

- A) Ectópica íntegra com beta-hCG baixo
- B) Gravidez ectópica ROTA / instabilidade hemodinâmica
- C) Massa anexial pequena
- D) Ausência de batimentos cardíacos fetais
- E) Paciente estável e assintomática

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente Rh negativo tratada por gravidez ectópica. Qual conduta adicional é necessária?

- A) Nenhuma
- B) Administrar imunoglobulina anti-D para prevenir aloimunização
- C) Transfusão de plaquetas
- D) Anticoagulação plena
- E) Corticoide

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual exame NÃO pode faltar diante de abdome agudo em mulher em idade fértil?

- A) Beta-hCG (excluir gravidez ectópica)
- B) Eletroencefalograma
- C) Radiografia de tórax
- D) Espirometria
- E) Dosagem de amilase apenas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Atraso menstrual + dor súbita + hipotensão/taquicardia + beta-hCG positivo + líquido livre = gravidez ectópica rota com choque hemorrágico. Conduta: cirurgia de emergência (salpingectomia) com reanimação simultânea (acessos calibrosos, hemoderivados), sem aguardar exames adicionais.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A tuba uterina é a localização mais comum da gravidez ectópica (cerca de 95%). Outras localizações (cornual, ovariana, cervical, cicatriz de cesárea) são menos frequentes, mas algumas têm maior risco de hemorragia grave.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O metotrexato é contraindicado na gravidez ectópica ROTA e na instabilidade hemodinâmica — nesses casos o tratamento é cirúrgico de emergência. O metotrexato é opção apenas na ectópica íntegra, estável e com critérios favoráveis.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Paciente Rh negativa deve receber imunoglobulina anti-D após gravidez ectópica (como em outros eventos com sangramento na gestação) para prevenir a aloimunização e a doença hemolítica em gestações futuras.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Em toda mulher em idade fértil com abdome agudo/dor pélvica, o beta-hCG é obrigatório para excluir gravidez ectópica — uma causa potencialmente fatal que pode se manifestar como abdome agudo e choque.

SM24
Suporte ao Plantão Médico